

## 高血压病治疗中的药物相互作用

王维克

(黑龙江省商业职工医院, 黑龙江 哈尔滨 150010)

**【摘要】**目的 探讨高血压疾病治疗中的药物相互作用。方法 在2013年中选取高血压疾病患者100例作为研究对象, 对患者日常应用的治疗高血压的药物进行分析观察, 并对患者使用这些药物后的疗效进行药效分析, 并对结果进行讨论。结果 高血压疾病患者在临床使用多种降压药物的治疗案例中, 证明高血压治疗药物具有相互作用性。结论 在患者治疗高血压过程中, 所使用的不同降压药物之间会有相互作用, 因此患者在使用多种降压药物时, 应对药物成分进行了解, 谨慎合理的使用, 避免因药物互相作用使患者的身体出现不良症状, 确保在患者使用药物安全、可靠、有效。

**【关键词】** 高血压疾病; 降压药物; 相互作用**【中图分类号】** R544.2; R969.3**【文献标识码】** B

长期高血压患者在心血管方面易导致患者发生心血管疾病, 并且对患者心、肝、脾、肺、肾和脑等功能会造成一定损伤影响, 严重时对这些器官的功能会有衰竭性的影响<sup>[1]</sup>。在治疗高血压的过程中, 根据心血管疾病和高血压患者之间的联系, 在治疗措施中增加预防心血管疾病发生的药物, 最大限度降低高血压患者引发心血管疾病的可能性<sup>[2]</sup>。高血压患者对自身病情的控制与药物的使用息息相关, 多种药物的联合使用, 对患者产生的效果具有药物间的相互作用性。本研究对此作出报告, 具体如下。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

在2013年中选取高血压疾病患者100例作为研究对象, 其中男54例, 女46例, 年龄40.25~80.22岁, 平均年龄(48.23±5.22)岁, 病程在1.23~75.56个月, 平均病程(50.23±23.21)月。小学文化程度以下30例, 小学文化程度30例, 初中文化程度20例, 初中以上文化程度20例。高血压一级45例, 二级55例。原发性高血压32例, 肥胖因素导致的高血压20例, 精神因素导致的高血压30例, 因性激素导致的高血压18例。44岁之前的高血压患者男性多于女性, 男35例, 女15例; 65岁之后女性高于男性, 女31例, 男19例。患者实验前均对实验有足够的了解, 并且自愿参与, 可以随时退出, 符合伦理学原则。患者的性别、年龄、等资料方面比较差异无统计学意义( $P>0.05$ )。

### 1.2 方法

对患者日常应用的治疗高血压的药物进行分析观察, 对患者使用这些药物后的疗效进行药效分析, 并对结果进行讨论。

患者所使用药物分类分级。按照药物作用效果对药物进行分类, 分别有: ①对患者的神经系统产生影响的药物, 此类药物通常可以帮助外周血管中血液流动通畅, 对心脏输出量有一个减少作用, 从而使患者的血压降低, 并同时使患者的心率减慢。在临床使用中, 通常用以治疗重度情况的高血压症状。例如莫索尼定、可乐定等; ②对患者有着神经阻断效果的药物有咪噻芬和美加明等, 此种药物可以使患者的部分神经节功能被阻断, 由于在临床运用中此类药物容易引起患者对药物的耐受性, 现较少使用。目前在临床中, 使用此类药物的患者类型通常为: 使用其他降压药物无效, 患者重度高血压, 出现危险症状。通常用以迅速降低患者高血

压; ③对患者肾上腺素能够进行神经传递物质的药物包含利血平等; ④对患者肾上腺素进行阻断的药物。此类药物通常具有可以阻断患者肾上腺素的作用, 此类药物有特拉唑嗪、拉贝洛尔等; ⑤对患者的血管进行扩张, 此种类型的药物通常有二氮嗪、硝普钠等; ⑥对患者的肌细胞进行松弛和平滑作用, 并且为患者舒张血管降低高血压的药物通常有硝苯地平、尼卡地平、尼索地平等。此类药物的降压作用通常与药物使用剂量有关, 对患者的心脏输血量有减少作用, 并且能治疗患者的心绞痛症状; ⑦具有有利于患者利尿性质的药物。此类药物在临床运用中, 是治疗高血压患者的首选, 为高血压疾病阶梯性治疗的药物。在使用方法上此种药物既可以单独使用, 也可与其他降压药物联合使用, 对高血压患者的治疗效果有增强的作用, 并对其他药物引起的不良反应有减轻效果; ⑧血管紧张素转化酶药物有卡托普利、依那普利、福辛普利等。此类药物可以在患者的血压中起到调节作用。血管紧张素转化酶抑制药物可以在患者肾素、血管紧张素等方面造成干扰, 有效的降低患者血压, 使高血压患者心力衰竭情况和病死情况得到缓解。血管紧张素转化酶抑制药物可在血糖高、血脂高等危险因素的影响下, 对患者血管产生有利影响。

以上药物在临床运用中, 当患者病情出现需要时, 药物间可联合运用。

### 1.3 观察指标

药物之间互相作用是否对患者产生不良反应。

### 1.4 数据处理

数据采用SPSS 13.0软件处理, 数据资料采用例数( $n$ )表示, 以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

## 2 结果

患者案例中, 10例老年患者出现不良药物反应; 8例孕妇患者对药物的联合使用有不良反应, 对胎儿造成影响; 有8例患者精神方面出现注意力涣散情况。

## 3 讨论

因老年患者年迈体弱, 高血压药物联合使用对老年患者造成的影响较为明显, 用药方案需考虑患者具体情况。孕妇使用高血压联合降压药物, 会对患者产生一定的危险性, 所以在使用药物治疗高血压孕妇患者时, 应考虑患者腹中胎儿对药物的承受力, 做到既不损伤胎儿又能有效治疗患者高血压; 由于降压药物对血压的控制, 可能导致脑

# 社区中老年高血压患者血浆同型半胱氨酸水平测定的临床探讨

王玉梅, 侯丽丽  
(北京市昌平区回龙观社区卫生服务中心检验科, 北京 100096)

**【摘要】目的** 研究分析社区中老年高血压患者血浆内同型半胱氨酸含量的检测情况。**方法** 选择2014年1月~10月在本社区的50例高血压患者作为观察组, 并选择同期在本社区体检的50名正常者作为对照组, 均进行血浆同型半胱氨酸检测。**结果** 观察组患者的血浆同型半胱氨酸水平显著高于对照组, 差异有统计学意义( $P<0.05$ )。并且, 观察组患者血浆同型半胱氨酸 $>10\text{ }\mu\text{mol/L}$ 的概率显著高于对照组, 差异有统计学意义( $P<0.05$ )。**结果** 社区中老年高血压的发生可能与血浆同型半胱氨酸有紧密相关性, 血浆同型半胱氨酸检测早期筛查、防治具有重要意义。

**【关键词】** 社区; 高血压; 血浆同型半胱氨酸; 检测  
**【中图分类号】** R544.1 **【文献标识码】** B

在社区老年人群中, 高血压疾病是患病率较高的一种, 很容易引发心脑血管疾病。据不完全统计<sup>[1]</sup>, 患有原发性高血压的患者发生心血管疾病的可能性约为正常人的25倍以上, 对社区中老年人的健康、生命具有严重的威胁。血浆同型半胱氨酸(Hcy)是蛋氨酸代谢生成的一种含硫基中间产物, 是心脑血管疾病的一项重要独立性危险因素。现选择本社区的50例高血压患者, 检测其同型半胱氨酸水平, 并与正常人的水平相对比, 研究如下。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

选择2014年1月~10月在本社区的50例高血压患者作为观察组, 并选择同期在本社区体检的50名正常者作为对照组。两组研究对象的一般资料经统计学分析, 差异无统计学意义( $P>0.05$ )。见表1。

### 1.2 方法

两组研究对象均采集清晨空腹血液, 采集量为3.0 mL, 然后常规血清分离, 通过循环酶法检测全部研究对象同型半胱氨酸水平<sup>[2]</sup>。

### 1.3 统计学分析

通过SPSS 15.0统计学软件对数据进行对比分析, 计量资料以“ $\bar{x}\pm s$ ”表示, 并采用配对样本 $t$ 进行检验; 计数资料以百分数(%)表示, 采用 $\chi^2$ 检验。以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

表1 两组患者的一般资料对比分析表(n)

| 一般资料                                  | 观察组   | 对照组   |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 男性/女性                                 | 22/28 | 18/32 |
| 年龄: $<40$ 岁                           | 8     | 34    |
| 40~50岁                                | 10    | 9     |
| 50~60岁                                | 14    | 7     |
| 60~70岁                                | 18    | 0     |
| Hcy: $0\sim20\text{ }\mu\text{mol/L}$ | 27    | 43    |
| 20~30 $\mu\text{mol/L}$               | 15    | 6     |
| 30~100 $\mu\text{mol/L}$              | 8     | 1     |

## 2 结果

观察组患者血浆同型半胱氨酸水平( $14.24\pm6.29$ )  $\mu\text{mol/L}$ 显著高于对照组的( $10.46\pm2.44$ )  $\mu\text{mol/L}$ , 差异有统计学意义( $P<0.05$ )。并且, 观察组患者血浆同型半胱氨酸 $>10\text{ }\mu\text{mol/L}$ 的概率显著高于对照组, 差异有统计学意义( $P<0.05$ )。见表2。

表2 两组患者的同型半胱氨酸检测结果分析表[n(%)]

| 分组  | n  | $<10\text{ }\mu\text{mol/L}$ | 10~15 $\mu\text{mol/L}$ | $>15\text{ }\mu\text{mol/L}$ |
|-----|----|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 观察组 | 50 | 11 (22)                      | 24 (48)                 | 15 (30)                      |
| 对照组 | 50 | 42 (84)                      | 8 (16)                  | 0 (0)                        |

供血量降低, 联合使用降压药物时, 应对药物服用时间和需要集中精神的时间做一个合适的安排, 使之间隔开<sup>[3]</sup>。在患者治疗高血压过程中, 所使用的不同降压药物之间会有相互作用, 因此患者在使用多种降压药物时, 应对药物成分进行了解, 谨慎合理的使用, 避免因药物互相作用使患者的身体出现不良症状和并发症的发生, 确保在患者使用药物安全、可靠、有效<sup>[4-5]</sup>。

## 参考文献

[1] 陈良华. 高血压药物的相互作用[C]. 海南省药学会2010年学术

年会会议论文集, 2010: 292-293.

- [2] 金平. 如何选择治疗高血压的药物[J]. 中外健康文摘, 2010, 7(5): 33-34.
- [3] 刘金岩, 孙力, 于鲁海, 等. 高血压专科临床药师的临床实践体会[J]. 新疆医学, 2013, 43(1): 111-112.
- [4] 江连湖. 抗高血压药物的相互作用及不良反应. 中国现代药物应用[J]. 2011, 12(24): 77-78.
- [5] 李俭春. 基层医生如何合理选择治疗高血压的药物. 中华全科医师杂志[J]. 2007, 10(10): 67-69.